

PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN

NEUROLOGÍA – ATENCIÓN PRIMARIA

V02_Mayo 2022

**HOSPITAL REINA SOFIA -
DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA-GUADALQUIVIR**

Con el objeto de mejorar la comunicación entre la UGC de Neurología del Hospital Reina Sofía y las distintas UGCs del Distrito Córdoba y Guadalquivir, se ha establecido un grupo de trabajo con profesionales de los dos ámbitos asistenciales, que además de dar respuesta a las incidencias que se generan en la práctica diaria, garantice la mejora en la calidad asistencial en los pacientes.

Para ello, se establecen unos criterios de derivación por parte de Atención Primaria que permitan la actuación en acto único por parte de Atención Hospitalaria, y a su vez mejoren la comunicación y resolución de incidencias entre ambos niveles asistenciales, evitando que se generen consultas innecesarias y repetición de trámites administrativos ajenos a su práctica asistencial.

Para ello, se establecen los siguientes grupos de patología por motivos de consulta.

1.- DETERIORO COGNITIVO y DEMENCIAS

Entendemos por deterioro cognitivo las alteraciones en el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, el juicio y la toma de decisiones. Los signos del deterioro cognitivo incluyen la pérdida de memoria y dificultad para concentrarse, completar actividades, comprender, recordar, seguir instrucciones y solucionar problemas. Otros signos frecuentes son trastornos en el estado de ánimo o cambios de comportamiento, pérdida de motivación y desorientación.

El deterioro cognitivo puede ser leve o grave y sus causas son muchas, desde el fallo de memoria asociado a la edad (pérdida similar al de otra persona de su misma edad) hasta enfermedades tipo Alzheimer o debidas a otros procesos como la demencia vascular o multiinfarto.

Se considera demencia cuando el deterioro cognitivo afecta a más de un dominio, suponer un cambio respecto al nivel previo del paciente y ser lo suficientemente intenso como para provocar en el paciente una limitación funcional en sus actividades sociolaborales o familiares.

El deterioro cognitivo se puede **clasificar** en:

- Tipo amnésico: Afecta de forma característica al área de la memoria, sobre todo la episódica (capacidad de aprender y retener información nueva). Es la más frecuente y la que de forma más habitual evoluciona a Enfermedad de Alzheimer.
- Tipo no amnésico: Predomina el deterioro en cualquiera de las otras zonas cognitivas más que en la memoria, de forma aislada o de varias a la vez.

El **diagnóstico** es fundamentalmente clínico, y el principal objetivo ante su sospecha es descartar causas tratables, establecer el nivel de deterioro y planificar su seguimiento, por lo que en todos los casos de sospecha de deterioro cognitivo debe realizarse:

- **Anamnesis del paciente** centrada en antecedentes familiares de demencia, forma de inicio, historia previa de traumatismo...

En este apartado es fundamental descartar causas tratables como la polifarmacia y revisar posibles medicaciones que pueden afectar a la memoria como Benzodiacepinas, Antidepresivos Tricíclicos, Anticonvulsivos, Opioides, Sedantes hipnóticos no benzodiacepínicos o anticolinérgicos usados para el tratamiento de la incontinencia.

- **Entrevista con el familiar o el cuidador**, en la que debe verificarse un cambio significativo de pérdida de memoria en relación a su situación previa.
- **Exploración física** centrada en el área neurológica,
- **Analítica**, se recomienda realizar un hemograma, determinación de sodio, potasio, calcio, glucosa, función renal y hepática, hormonas tiroideas, niveles de vitamina B12 y ácido fólico así como la serología de sífilis. **Para facilitar esta determinación de adaptará el perfil de laboratorio de Deterioro cognitivo para incluir estos parámetros.**
- **Estudios de la función cognitiva**, el más empleado es el mini examen del estado mental (MMSE) o *mini-mental test*, con una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de demencia en población de 65 en el ámbito de la AP.

Siempre que sea posible, es conveniente completarlo con otros test como el Test del Informador o el Fototest (preferible en bajo nivel cultural, analfabetismo o estudios primarios)

- **Pruebas de neuroimagen** (TAC de cráneo sin contraste) en los pacientes con sintomatología clínica de inicio compatible con déficit cognitivo, de evolución lenta, y en los que los test de valoración cognitiva son positivos.

La solicitud incluirá en todos los casos información clínica (edad, sintomatología, duración de los síntomas y hallazgos exploratorios que puedan orientar hacia el tipo de demencia, etc.) especificando “**sospecha de déficit cognitivo**” y aportando el valor e interpretación de los test de evaluación cognitiva realizados. **No se solicitarán pruebas de neuroimagen en pacientes ya diagnosticados o para seguimiento**

Tendrán **criterio de derivación por Teleconsulta** a Neurología:

- Pacientes con **sospecha de deterioro cognitivo con clínica y test compatibles**, para confirmación diagnóstica e inicio de tratamiento si procede.

- **Pacientes ya diagnosticados**, que tras periodo de seguimiento por parte de neurología y en periodo de estabilización sin revisiones pendientes, **presentan**:
 - o Deterioro rápidamente progresivo de funciones conservadas hasta ese momento (excluyendo proceso intercurrente o síndrome confusional)
 - o Sintomatología de reciente aparición y de difícil manejo tras inicio de tratamiento en Atención Primaria (Agitación con o sin agresividad, alteración del patrón de sueño, alucinaciones, sobre todo visuales, e ideas delirantes).
- Pacientes con posibles **efectos secundarios del tratamiento** antidepresión que puedan precisar ajuste de dosis o cambio de principio activo **y/o pacientes** que, tras el alta de las CCEE de Neurología para seguimiento por Atención Primaria y tras su valoración anual, se determine **que no precisa continuación del tratamiento. (Anexo_1)**

Toda **derivación por Teleconsulta** a Neurología, deberá **realizarse con**:

- **Anamnesis detallada**, con descripción de los síntomas y su repercusión sobre las actividades diarias.
- **Exploración neurológica básica.**
- **Analítica de sangre**, con **perfil Deterioro cognitivo**.
- **Resultados** de los **Test cognitivos** realizados.
- **TAC de Cráneo. Solo en pacientes no diagnosticados.**

Tras la valoración del paciente, desde **Neurología** se **emitirá un informe** dónde se especifique de forma inequívoca:

- **Diagnóstico, pronóstico y tratamiento**, sobre todo en aquellos casos en los que se haya desestimado el inicio de tratamiento o no procedan nuevas revisiones.

Para facilitar a los profesionales la información a aportar, es aconsejable la cumplimentación de los datos a través de la plantilla de deterioro cognitivo, creada como herramienta de ayuda, si bien, la no cumplimentación de ésta no podrá ser motivo de rechazo de la derivación siempre y cuando la información facilitada por el profesional cumpla con los requisitos antes mencionados y sea suficiente para que desde Atención Hospitalaria puedan tomar una decisión sobre las necesidades de valoración del paciente.

Cualquier derivación no atendida por Neurología deberá indicar el nombre del profesional que la rechaza, así como el motivo por el que esta se produce, que deberá quedar claramente identificado para poder así ser corregido para un nuevo envío.

2.- CEFALEAS y NEURALGIAS

Aunque las cefaleas y neuralgias del trigémino no son candidatas a una derivación a Neurología por Teleconsulta, podrán ser subsidiarias de una teleconsulta con neurología:

- **Cefaleas y neuralgias del trigémino ya diagnosticadas por neurología,** estabilizadas en su proceso y controladas con tratamiento, **que tras un periodo de latencia, presentan reagudización de su proceso** con aumento del número de episodios e intensidad, pero **que asemejan al cuadro inicial** y dónde no se ha obtenido respuesta tras la reintroducción de los tratamientos preventivos que en su momento fueron efectivos.

EN RESUMEN:

El objetivo de estos acuerdos es facilitar la consulta en acto único por parte del servicio de neurología, mejorando su capacidad de resolución y accesibilidad a otros pacientes del SSPA.

Para ello, se establece que:

- 1.- Toda derivación a neurología deberá realizarse con unos mínimos criterios de calidad en los que de forma inexcusable se informe del tiempo de evolución y el tratamiento empleado cuando proceda. La no inclusión de esta información en la derivación podrá ser motivo de devolución por falta de información.
- 2.- Toda sospecha de patología subsidiaria de ser valorada por neurología o duda diagnóstica, será remitida para su valoración con los criterios antes mencionados. Tras la valoración, el servicio de neurología emitirá en todos los casos un informe a través de Diraya, donde de forma inequívoca conste si se procede al alta o si procede revisión, en cuyo caso, será gestionada directamente por el servicio.
- 3.- Para los pacientes que tras su valoración se indique un tratamiento o recomendaciones para el paciente, todas las prescripciones necesarias se realizarán a través de la aplicación de RXXI, y en caso de precisar revisión, con fecha de validez hasta la siguiente revisión.
- 4.- Los pacientes que ya han sido valorados por un motivo de consulta concreto con informe de alta por parte del servicio de neurología y en donde su médico de familia entienda que la evolución no es satisfactoria, se contactará con el neurólogo de referencia por medios telemáticos, y en caso de consensuar una nueva valoración, esta se generará como revisión a través de la UAC.
- 5.- Si tras una consulta con neurología, este determina que procede otra consulta con cualquier otro servicio hospitalario, esta se hará a través de Interconsulta Hospitalaria y no a través de Atención Primaria.
- 6.- El servicio de neurología garantizará la comunicación telemática con los centros de atención primaria, nombrando referentes en cada uno de los centros y dando respuesta a las dudas y consultas solicitadas en el plazo establecido.
- 7.- El sistema de derivación por Teleconsulta cumple con todos los derechos de garantía en los tiempos de respuesta al paciente, por lo que su acceso desde Atención Primaria estará permanentemente operativo.
- 8.- El grupo de trabajo entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria mantendrá reuniones periódicas para valorar en cumplimiento de estos acuerdos.